2026학년도 내과 학년말고사 (260417)

* 총 60문항(62?문항 복기), 60분 시험(CBT)
* 과별로 출제된 문제 수 및 분류가 정확하지 않을 수 있습니다. 발문이 길어 시간 부족한 시험이었습니다.

[심장내과] 11문항

1. 82세 남성이 70년 동안 담배 피고 술 먹었는데 하지의 위약감으로 내원하였다. 평소에 등산을 즐겼으나 걸을 때마다 아파서 최근에는 하지 못했다. 당뇨랑 고혈압이 있었고, vital sign이 혈압이 150/90이었고 호흡이랑 맥박, 체온은 정상이었다. 아래는 ABI 시행 결과와 (ABI 사진: 오른쪽 다리 0.7, 왼쪽 다리 0.61) CT angio 사진이다. 시행할 수 있는 처치는?



① 경피적혈관개통술
② 스테로이드

2. 심음청진 상 흉골 우측 2번째 갈비사이공간에서 수축기 심잡음 들렸고 목 쪽으로 방사되어 들린다. 경정맥 확장은 없었다. 진단은?

① Aortic stenosis
② Tricuspid regurgitation
③ Mitral stenosis

3. 다음 심초음파에서 노란색으로 표시된 구조물의 이름은?



① 우심방
② 우심실
③ 좌심방
④ 좌심실
⑤ 상대정맥

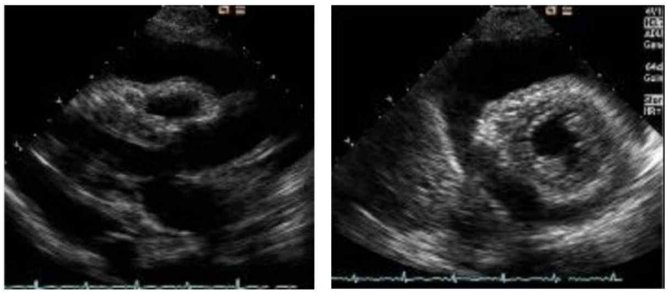
4. 44세 남성이 3시간 전부터 시작된 가슴 중앙에 누르는 듯한 통증으로 내원. 움직이면 심해지고 쉬면 나아지는 양상이었다. 5년 전부터 고혈압 약 복용중이었다. BP 90/50 HR 120 정도이며 CK-MB 1800, Troponin 200 정도로 상승되었다. 진단은?



(심전도 : aVF lead ST-elevation 있었고, aVL, V1, V2, V3에 reciprocal ST-depression 있었음.)

① ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI)
② Non ST-segment elevation myocardial infarction (NSTEMI)
③ Unstable angina

5. 54세 여자가 하루 전부터 숨이 차서 응급실에 내원하였다. 1년 전부터 유방암 치료받았다. BP 70/40mmHg, HR 110/min, RR 22/min 체온 36.4℃ 이다. 가슴 청진에서 심음이 작게 들리고 호흡음은 정상이다. 경정맥의 높이가 복장각에서 8cm 높이에서 측정된다. 심초음파 결과는 다음과 같다. 치료는?



① 응급 심낭천자
② 가슴관 삽입
③ 이뇨제 사용
④ 글루코코르티코이드
⑤ 경과 관찰

6, 88세 여자가 5일 전부터 발생한 호흡곤란으로 응급실에 왔다. 고혈압과 부정맥의 과거력이 있다. 혈압 110/78mmHg, 맥박수 84/min, 체온 36.5, 호흡 28/min이다. 증상 호전을 위한 약물은?





① 경구 이뇨제
② 경정맥 이뇨제
③ 광범위 항생제
④ 경구 항응고제
⑤ 경구 스테로이드

7. Heart failure로 입원한 환자가 퇴원할 예정이다. 환자에게 고지혈증에 대해 처방할 약제로 가장 적합한 것은?

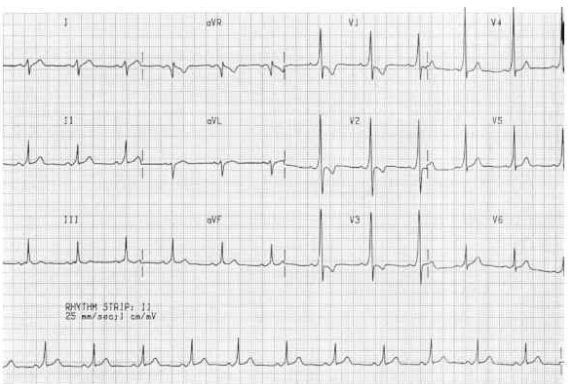
① Statin
② Bempedoic acid
③ PCSK9 inhibitor

8. 운동하면 다리에 통증이 발생하고 쉬면 나아지는 증상으로 내원한 환자. 발등동맥 맥박이 촉지되지 않는다. 선별검사로 가장 적합한 것은?

① Ankle-brachial index (ABI)
② CT angiography
③ 말초동맥 초음파

9. 17세 남성이 어지러움, 두근거림을 주소로 내원했다. 응급실 도착 당시 혈압은 90/47 mmHg였다. 응급실에서 약물 투여 후 두근거림은 호전되었다. 아래는 약물 투여 전후 심전도이다. 환자에서 증상 완화를 위해 쓰인 약물로 적절한 것은?





① Procainamide
② Adenosine
③ BB
④ Verapamil
⑤ Digoxin

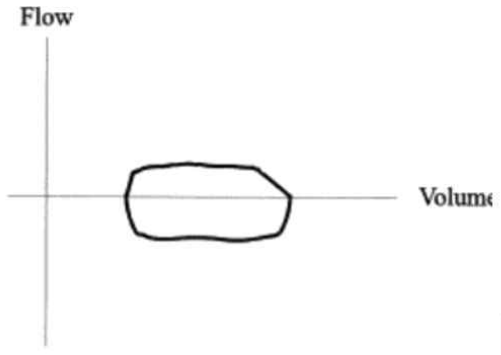
10. 24시간 혈압(야간 혈압 측정, 혈압변동 측정 포함)의 정확한 측정에 가장 좋은 혈압 측정 방법은?
① 병원 내 혈압 (Office BP)
② 가정혈압 (Home BP)
③ 손목 혈압 측정기
④ 활동 혈압 모니터링 (Ambulatory BP monitoring)
⑤ 중심 혈압 (Central BP)

11. 호흡곤란 증세가 있어 내원한 환자. 양쪽 폐 하부 수포음이 들린다. Pretibial pitting edema가 있다. 의심되는 질환의 진단을 위해 필요한 검사는?
① Echocardiography
② Chest CT

[호흡기내과] 11문항
12. 70세 남성이 6개월 전부터 서서히 진행된 호흡곤란과 마른기침으로 내원하였다. 30갑년의 흡연력이 있었다. 3개월 전 타 병원에서 천식으로 진단받고 흡입 스테로이드를 처방받아 복용 중이었으나 증상은 호전되지 않았다. 혈압 130/80mmHg, 맥박 98회/분, 호흡 26회/분, 체온 36.8도, SpO_2 80%였다. 청진상 양측 하폐야에서 흡기 말 수포음이 청취되었다. 폐기능검사 결과는 다음과 같다. FVC 1.5L, FEV1 1.4L. 진단에 가장 적절한 검사는?
① HRCT (고해상도 컴퓨터단층촬영)
② 메타콜린 기관지유발검사
③ SPECT
④ PET-CT
⑤ 폐관류스캔

13. X-ray 주어짐. 다음 사진에서 관찰되지 않는 것은? (실제로 다 관찰되었고 NG tube만 없었음.)
① 비위관
② 비터널식 중심정맥카테터
③ 체외막산소공급장치
④ 터널식 중심정맥카테터
⑤ 말초삽입중심정맥카테터

14. 48세 여자, 천식으로 ICS 사용 중이나 호흡곤란 심해져 병원에 왔다. 2개월 전 천식 급성 발작으로 인공호흡기 치료 받은 적 있다. 환자에게 비강 캐뉼라 15L/min으로 산소를 투여하였으나 SpO_2 80%로 호전이 미미하였다. SpO_2 86%에 머물렀고, 호흡수 32회/분,
동맥혈가스분석(산소 투여 후): pH 7.30, $PaCO_2$ 55mmHg, PaO_2 58mmHg이었다. Lab 결과 상 Procalcitonin 0.3ng/mL, Influenza/COVID-19 PCR 모두 음성이었다. Flow-Volume curve는 다음과 같았다. 가장 적절한 처치는?



① 속효성 기관지확장제(SABA) 네뷸라이저 흡입
② 메틸프레드니솔론 125mg 정맥 투여
③ 기관삽관 후 기계환기
④ 기관지 스텐트 삽입
⑤ 흡입 스테로이드 용량 증가

15. 67세 남성, 3년 전 소세포폐암(Extensive stage) 진단받고 항암 2번 받고 호전 증세를 보였으나 구토, 복통 등의 항암 치료 부작용이 심해서 자의적으로 3개월 간 항암을 중단하였다. 환자의 증상 악화되어 입원 후 의사에게 "폐암은 잘 안 낫는다"라며 항암치료 거부하였다. 다음 중 의사가 해야 할 것으로 가장 적절한 것은?
① 호스피스 병원으로 환자를 보낸다.
② 설득해서 항암치료를 다시 시작하도록 한다.
③ 환자의 요구에 응하여 진통제만 투여한다.
④ 수술을 시행한다.
⑤ 방사선 치료를 시행한다.

16. 고관절 전치환술 시행 6일 후 갑자기 호흡곤란 호소 및 신체검사상 좌측 하지에 부종 관찰되었다. 진단으로 옳은 것은?



① 혈전폐동맥색전증 (Pulmonary thromboembolism)
② 무기폐 (Atelectasis)
③ 심근경색 (Myocardial infarction)

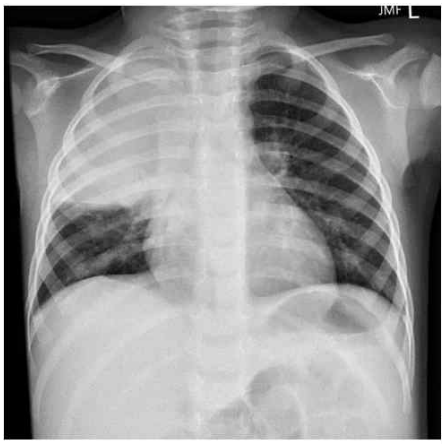
17. 65세 남성이 지역사회획득 폐렴으로 입원하여 Cefotiam(2세대 세팔로스포린) 와 Clindamycin 으로 치료를 시작하였다. 3일 후 체온 37.3도, WBC 12,400/㎕, CRP 82mg/L, 맥박 84회/분으로 임상적으로 호전되었다. 그러나 흉부 X-ray에서 우중엽의 경화 소견은 입원 시와 비교하여 변화가 없었다. 입원 당시 채취한 객담 및 혈액 배양 검사에서 MRSA가 검출되었다. 다음 중 가장 적절한 조치는?
① 2세대 세팔로스포린만 유지한다
② 클린다마이신만 유지한다
③ 레보플록사신(Levofloxacin)으로 변경한다
④ 2세대 세팔로스포린과 클린다마이신을 모두 유지한다
⑤ 반코마이신(Vancomycin)으로 변경한다

18. 58세 남성이 의식 저하 상태로 응급실에 내원하였다. 3일 전부터 기침과 발열이 있었으며 혈압 100/65mmHg, 맥박 108회/분, 호흡 28회/분, 체온 38.7도, SpO_2 82%. 자꾸 자려고 하고 세게 흔들면 눈을 뜬다.

- 동맥혈가스분석(실내 공기): pH 7.28, $PaCO_2$ 58mmHg, PaO_2 48mmHg, HCO_3^- 26mEq/L.
- 흉부 X-ray 우측 폐하엽에 무기폐(?) 주어짐.

다음으로 시행할 가장 적절한 처치는?
① 기관삽관 후 기계환기
② 비강 캐뉼라로 O_2 10L/min 투여
③ CPAP 적용
④ 가슴관 삽입
⑤ 기관지확장제 네뷸라이저 흡입 투여

19. 67세 남성이 3일 전부터 시작된 고열, 기침, 화농성 객담, 호흡곤란으로 응급실에 내원하였다. 당뇨병과 만성 간질환의 과거력이 있다. 혈압 75/42mmHg, 맥박 128회/분, 호흡 32회/분, 체온 39.6도, SpO_2 85%였고 의식은 drowsy 하였다. WBC 22,400/㎕, CRP 285mg/L, Cr 2.8mg/dL(baseline 0.9), Total bilirubin 3.2mg/dL, Platelet 68,000/㎕ 였다. 흉부 X-ray에서 우상엽에 광범위한 경화(consolidation)와 확인되었다. 이 환자의 초기 치료 원칙으로 옳은 것은?



① Norepinephrine을 투여하되, 장기 관류를 고려하여 평균동맥압(MAP) 80~85mmHg를 목표로 한다
② 배양 검사를 시행하되, 항생제 투여가 지체되지 않도록 1시간 이내에 광범위 경험적 항생제를 투여한다
③ 원인균이 확인된 후 표적 항생제를 투여한다
④ 30mL/kg 수액 투여 없이 승압제를 먼저 시작한다
⑤ 저용량 덱사메타손을 1차 치료로 투여한다

20. COPD 호흡곤란으로 치료 후 pH 7.40, $PaCO_2$ 50mmHg, PaO_2 50mmHg, SpO_2 84% 였다. 현재 환자가 호소하는 호흡곤란은 없다. 가장 적절한 조치는?
① 호흡 자극제 투여하여 $PaCO_2$를 40mmHg까지 낮춘다
② 저유량 산소를 투여하여 PaO_2 60mmHg 이상으로 유지한다
③ 증상이 없으므로 경과 관찰한다
④ 고유량 산소를 투여하여 PaO_2 90mmHg 이상으로 유지한다

21. 75세 할머니, 2개월 전 낙상으로 인한 대퇴골 골절로 수술하였음. 3일 전 호흡곤란 호소하였고 CXR, 호흡음, 심음 모두 정상이었음. 다음으로 해야할 처치는? (선지에 d-dimer는 없었음)
① HRCT

22. 50세 남성이 2주 전부터 시작된 발열(37.8~38.5도), 마른기침, 좌측 흉막통으로 내원하였다. 과거력상 특이 소견 없었다. 흉부 X-ray에서 좌측에 중등량의 흉수가 확인되어 흉수 천자를 시행하였다.

- 혈액 검사: Protein 7.0g/dL, LDH 180 IU/L - 흉수 검사: WBC 15,000/㎕(림프구 80%), ADA 90 IU/L, LDH 450 IU/L, Protein 5.2g/dL, Glucose 45mg/dL, pH 7.32. AFB 도말 음성, 결핵 PCR 음성, 세균 배양 음성 - X-ray(Rt. pleural effusion loculation 의심되는 X-ray 사진 주어짐)

가장 적절한 조치는?

① 항결핵제 치료한다

② 가슴관을 삽입

③ 광범위 항생제를 투여한다

④ 경과를 관찰한다

⑤ 비디오 흉강경 수술

[소화기내과] 10문항

23. 70대 남성, 혈변으로 내원한 환자. 평소 무릎 통증으로 NSAIDs 복용 중이었음. BP 80/50에 HR 120 Hb 9.1 일 때, 다음으로 시행할 처치는?

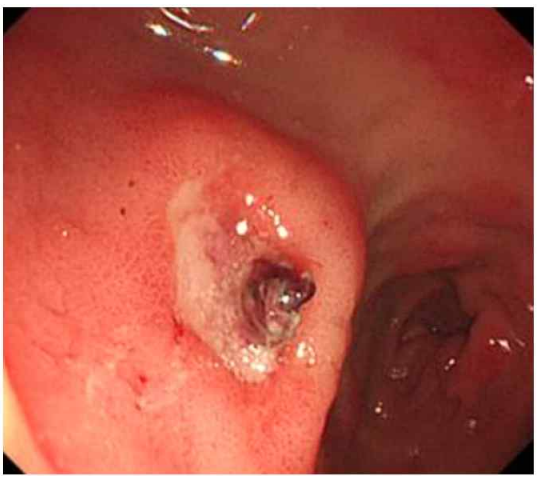
① 생리식염수를 주고 상부위장관 내시경 시행한다.

② Hb 7 이상이므로 농축 적혈구 수혈하지 않아도 된다.

③ 소장 출혈일 가능성이 있으니 캡슐 내시경 준비한다.

④ 혈역학적으로 불안정하니 응급 수술 준비한다.

24. 혈변 있고 V/S 90/60, Hb 7.6으로 확인되어 생리식염수 주입 후 내시경 시행하였다. 내시경 결과 위 저부에 미만성 궤양 있었고, Non bleeding visible vessel이 존재하고, CLO test가 양성으로 확인되었을 때 처치는?



① 응급 수술한다.

② H.pylori 제균치료부터 시작한다.

③ 내시경적 지혈술 진행한다.

④ 고용량 IV PPI 주고 경과 관찰한다.

25. 32세 여성, 변비를 주소로 내원하였다. 변은 1주일에 2회 정도 보았고, 염소똥처럼 나왔다고 한다. 복통이 동반되었고 변 본 후에 완화되었다. (Lab 결과는 모두 정상으로 제시) 다음 설명 중 옳은 것은?

① 궤양성 대장염이다.

② 과민성 장 질환 설사형에 해당한다.

③ 과민성 장 질환 변비형이므로 식이 섬유가 풍부한 식사를 권장한다.

26. 평소 변비가 있던 젊은 여성으로, 변을 닦을 때마다 피가 묻어나왔다. 변은 딱딱한 양상이었고 볼 때마다 힘을 주었다. 상부 위장관 내시경 및 하부 위장관 내시경에서 특이소견 발견되지 않았다. 이때 가장 가능성이 높은 것은?

① 치핵

② 궤양성 대장염

③ 대장 게실

④ 대장암

27. 60대 환자가 우측 결장암이 확인되어 우측 대장 절제술 진행하였다. 암의 위치를 고려할 때 환자가 호소하였을 증상으로 예상되는 것은?

① 뒤무직

② 두근거림

③ 복통

④ 변비

⑤ 변 가늘어짐

28. 80세 남성이 수주 전부터 시작된 연하곤란과 가슴통증을 주소로 내원하였다. 하루에 한 갑씩 60년 간 흡연하였고 매일 소주 1병씩 먹었다. 건강검진 결과 하부 식도암 (Squamous cell carcinoma, stage T3N1M0)으로 진단되었다. 다음 설명 중 옳은 보기는?

① 가장 흔하게 발생하는 동시성 암은 폐암이다.

② 국소 진행암이다.

③ 초음파 내시경으로 M staging 진행해야 한다.

④ 복합항암화학요법이 (이 선지 그대로 나옴)

⑤ 가장 흔한 발생 원인은 역류성 식도염이다.

29. 50세 여성이 오른쪽 상복부의 통증 및 발열을 주소로 내원하였다. 시행한 초음파 및 혈액 검사 결과는 다음과 같다. 올바른 것은?

WBC 18,000, CRP 12, bilirubin 2.1, LFT 정상

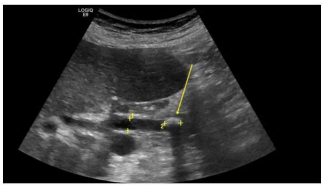
① 복강경하 담낭절제술
② 내시경적 역행성 담췌관 조영술
③ 항생제만 주고 돌려보낸다.
④ 수액 치료 후 경과 관찰

30. 34세 남성이 2주 전 시작된 피로를 주소로 내원하였다. 음주력은 없으며 HBV를 기저질환으로 가지고 있다. 시행한 혈액검사 결과는 다음과 같다. 다음으로 해야 할 것은?

AST/ALT 212/165, bilirubin 1.2, CBC 정상 HBe (-), Anti-HBe (+), Anti-HCV (+), Anti-HAV (+), HBV DNA 82*101 IU

① Tenofovir disoproxil fumarate 투여
② 확진을 위해서는 간 조직 검사가 필수적이다
③ HAV 급성기 간염으로 진단할 수 있다.
④ HCV RNA 검사한다.

31. 54세 여성이 오른쪽 상복부의 통증을 주소로 내원하였다. 혈액 검사 상 특이한 소견 없었으나 통증 계속 호소하여 수술 계획 하에 입원하였다. 입원 중 갑자기 통증 악화되고 황달 발생하여 CT 및 혈액검사 진행하였다. 옳은 치료는?

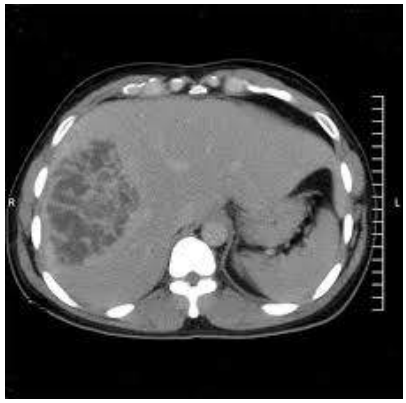



- 좌: 내원 당시 촬영한 초음파, 우: 악화 후 촬영한 CT
(둘 다 최대한 비슷한 사진으로 인터넷에서 가져옴)

Bilirubin 3.0, LFT 모두 정상, V/S normal

① 응급 수술
② ERCP
③ 경피경간 담도 배액술
④ 체외 충격파 쇄석술

32. XX세 환자가 3일 전 발생한 피로감 및 발열을 주소로 내원하였다. 다음 질환을 일으키는 균주 중 우리나라에서 가장 흔한 것은?



혈액검사: LFT 상승, CRP 상승, WBC 상승

① E. coli
② Streprococcus
③ Amoeba
④ Anaerobic bacteria
⑤ K. pneumoniae

[신장내과] 10문항

33. (Y) 만성신부전 4기 환자에게 권장하는 식단은?
① 고칼륨식이
② 고염분식이
③ 고단백식이
④ 고인산식이
⑤ 모두 아님

34. 복막 투석을 받고 있던 35세 여성이 내원하였다. 투석액은 혼탁하였으며, 3일 전 투석 연결부위를 실수로 떨어뜨렸다고 한다. 현재 복통과 구토를 호소하고 있다. 상기 환자에 대해 옳은 것을 고르시오
① 경정맥 항생제를 사용해야 한다.
② 복막 투석액의 조성 성분은 알부민이 대부분이다
③ 투석액의 저류 시간이 길어질수록 확산이 많이 된다.
④ 일반적으로 1회 투여 시 3~4L의 투석액을 주입하며, 보통 8~12시간 동안 저류한다.
⑤ 복막 투석은 혈액 투석에 비해 식이가 비교적 자유롭다.

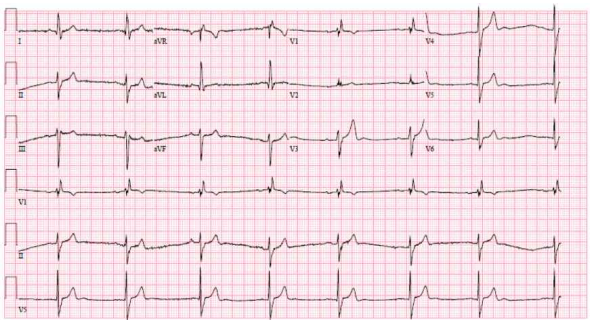
35. 급성 사구체 신염에 대해 옳은 것은?
① 신증후군의 경우 단백뇨가 1g/24hr으로 확인된 경우이다.
② 급속진행성 사구체신염의 경우 급성 사구체신염보다 빠르게 진행한다.
③ 혈뇨가 동반될 경우 미세변화 신증후군이나 막성 신증후군을 의심할 수 있다.
④ 혈관염이나 감염에 의해서도 사구체 신염이 발생할 수 있다.
⑤ 단독 혈뇨인 경우 IgA nephropathy 와 미세변화신증후군이 있다.

36. 급성신손상에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 내인성 중 가장 흔한 원인은 약제 유발과 사구체신염이다.
② 신전신손상과 간신증후군과 감별해야한다.
③ SGLT2 inhibitor와 NSAIDs는 Pre-renal AKI를 유발할 수 있다.
④ 급성세관괴사는 혈액 관류가 개선되면 금방 호전된다.
⑤ eGFR의 감소만으로 진단 가능하다.

37. 만성 신부전 4기 환자가 어지럼증을 주소로 내원하였다. 호흡곤란 호소하며, Hb는 저하되어 있다. 상기 환자에 대해 옳은 것은?
① 철분제를 주기 전에 조혈제를 충분히 투여해야한다.
② 심박출량이 증가할 수 있다.
③ 일차적인 원인은 혈색소 이상이다.
④ 만성신부전 5기에서 나타난다.

38. 28세 여성이 1달 전부터 시작된 무기력감으로 내원하였다. 내원 5일전부터 감기증상으로 감기약 복용하였으며 3일 전 항생제 복용하였다. 3일 전부터 신장 관련 증상 발현. 검사 소견은 다음과 같다.
혈액 : Hb 8, WBC 3,500/mm3 Plt 85,000/mm3
BUN/Cr 28/2.4mg/dL
소변 : 잠혈(-) 단백질(2+) RBC 0~1/HPF WBC 10~18/HPF, WBC cast (+)
① 진통제신장병
② SLE
③ 중금속신병증
④ 다낭성신장병

39. 70세 여성이 피로하여 내원하였다. 만성신부전 5기 환자로 현재 투석 치료는 하지 않고 약물적 치료만 진행 중이다. 몸에 기력이 없어 평소 토마토를 자주 갈아마셨다고 한다. 호흡 곤란은 없었고 소변량이 감소하였다. 해당 환자의 EKG 소견은 다음과 같아. 다음 중 가장 의심되는 전해질 문제는 무엇인가?



① Hyperkalemia
② Hypercalcemia
③ Hyponatremia
④ Hypochloremia
⑤ Hypocalcemia

40. 26세여성이 IgA 신병증으로 현재 ARB 복용중이다. 환자의 단백뇨 수치가 2460mg/gCr이었다가 600mg/gCr으로 호전되었다. 추가적인 단백뇨 감소를 위해 사용할 수 있는 약제는?
① SGLT2 inhibitor
② ARNI (Angiotensin receptor-neprilysin inhibitor)
③ ACE inhibitor
④ Loop diuretics
⑤ Finerenone

41. 62세 남성이 당뇨병의 병력이 있다. 최근 호흡곤란이 심해져서 내원하였고 신장내과로 협진을 의뢰받았다. eGFR=68, 혈당 8.3%이었고, X-ray 상에서 심비대 및 흉수는 관찰되지 않았으며 심장초음파 검사 결과 EF=63%이었다. 이 환자에게 사용할 수 있는 약제로 옳은 것은?
① Glucagon like peptide 1 agonist
② Dipeptidyl peptidase 4 inhibitor
③ SGLT2 inhibitor
④ Sulfonylurea
⑤ Insulin

42. 상습적으로 요로감염이 있는 여성에게서 감염을 예방할 수 있는 생활습관 원칙이 아닌것은?
① 비데를 이용하여 청결하게 씻는다
② 공동목욕탕이나 수영장 이용 후 배뇨한다
③ 소변과 대변을 앞에서 뒤로 닦는다
④ 물을 많이 마신다
⑤ 소변을 참지 않는다

[내분비내과] 5문항
43. 61세 남자, 8년 전에 고혈압 진단받았다. Metformin 1000mg + ARB 복용 중이며, HbA1c 7.5%이다. 당뇨병 진행을 늦추기 위해 줄 수 있는 약은?
① ACE inhibitor
② Beta Blocker
③ DPP-4 inhibitor
④ TZD
⑤ SGLT2 inhibitor

44. 55세 환자가 3년 전 당뇨 진단 받고 생활습관 교정을 시행하였으나 잘 조절되지 않았다. HbA1c 10%, proteinuria ++, 그 외 RUA 정상이었다. 처방할 약으로 가장 적절한 것은?
① Metformin
② Metformin + GLP-1 agonist
③ Metformin + SGLT-2i

45. 8세 남아가 피로, 근력저하로 내원하였다. Lab 결과에서 Ca 증가, P 감소 소견을 보였고, EKG에서 QT 간격 감소한 소견을 보였다. 이후 시행할 검사로 가장 적절한 것은?
① 25(OH)D
② 1,25(OH)2D
③ PTH
④ PTHrP

46. (Y) 34세 여자 환자로 Hashimoto's Thyroidits로 진단 받 고 Levothyroxine 100mcg 처방 받아 매일 공복 식전에 꾸준히 복용하고 있는 상태이다. 검사 결과상 TSH 1.22㎕IU/mL, Free T4 1.7ng/dL(참고치 0.8~1.68)이다. 앞으로의 치료 계획은?
① 현재 복용량 유지
② Levothyroxine 12.5mcg 증량
③ Levothyroxine 25mcg 증량
④ Levothyroxine 12.5mcg 감량
⑤ Levothyroxine 25mcg 증량

47. 임신 9주 임산부 Graves disease 진단받고 Propylthiouracil 복용하고 있는 상태이다. 검사 결과상 TSH 1.22㎕IU/mL, Free T4 1.7ng/dL(0.8~1.68)이다. 앞으로의 치료 계획은?
① 현재 복용량 유지
② 아이 때문에 Methimazole로 변경
③ Propylthiouracil 증량
④ 약물 중단 후 경과관찰
⑤ PTU+levothyroxine 준다

[감염내과] 5문항
48. 20세 여성 환자가 5일 전부터 열이 났고, 3일 전부터 몸통과 사지에 아래 사진과 같은 발진이 났다. 일주일 전 5세 영아와 접촉한 바 있다. 이 환자를 진료하는 의료진이 착용해야 하는 보호 장비로 옳은 것은?



(출처: 구글 / 실제는 성인 여성 손 사진)
① (사진) 비닐장갑
② (사진) 덴탈마스크
③ (사진) N95 마스크
④ (사진) 전신 보호구
⑤ (사진) 알코올 세정제

49. 65세 남성이 지역사회획득 폐렴으로 입원하여 2세대 cephalosporin과 clarithromycin으로 치료를 시작하였다. 3일간 치료하고 발열은 임상적으로 호전되었으며 흉부 x-ray 소견은 변화가 없었다. 환자는 호전된 상태이지만, 이후 항생제 감수성 결과가 나와 MRSA로 확인되었다. 사용해야 할 항생제로 옳은 것은?
① fluoroquinolone만 투여
② 2세대 cephalosporin만 투여
③ clarithromycin만 투여
④ 2세대 cephalosporin과 clarithromycin 유지
⑤ vancomycin 투여

50. 본과 실습생이 환자가 사용한 란셋(바늘)에 찔렸다. 다음 중 하지 말아야 하는 것은?
① 환자 감염 상태를 확인한다.
② 혈액노출보고서를 작성한다.
③ 다른 사람들이 바늘에 찔리지 않게 두 손으로 뚜껑을 꽉 닫는다.
④ 상처를 흐르는 물에 씻는다.
⑤ 실습생의 B형간염 항체 여부를 확인한다.

51. 32세 여성 임산부. 재태주수 14주차로 산전진찰을 시행하였다. 소변에서 E.coli가 배양되었으나 발열이나 특별한 배뇨 증상은 없었다. 이후로 시행한 산전진찰에서도 여러번 반복적으로 검출되었다. 다음 중 적절한 조치를 고르시오.
① 다음 외래 때 검사한다.
② 추후 증상이 생기면 검사한다.
③ 증상이 없으므로 치료하지 않는다.
④ 무증상 세균뇨로 판단하고 항생제 투여한다.
⑤ 방광요관역류가 의심되므로 신장 초음파 검사를 시행한다.

52. 72세 여성이 우상복부 통증, 발열, 오한으로 응급실에 내원하였다. 복부 초음파에서 담낭벽 비후와 담석이 확인되어 급성 담낭염이 의심된다. 과거력상 만성 신질환(CKD stage 3), 고혈압, 당뇨병이 있다. 2개월 전 외래 방문 시 Cr 1.2mg/dL, Total bilirubin 0.8mg/dL, Platelet 220,000/㎕, 혈압 135/82mmHg 였다. 응급실 내원 시 혈압 95/58mmHg, 맥박 112회/분, 호흡 24회/분, 체온 38.9도, SpO_2 94%, Cr 2.1mg/dL, Total bilirubin 2.4mg/dL, Platelet 145,000/㎕, Lactate 3.1mmol/L 이었다. 다음 중 이 환자의 상태 평가에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 기존의 장기 부전(만성 신질환)이 있으므로 SOFA-3를 적용할 수 없다
② qSOFA 2점 이하이므로 패혈증이 아니다
③ 감염이 의심되는 환자에서 기저 SOFA 점수 대비 2점 이상 급성 상승 시 패혈증으로 진단할 수 있다
④ 크레아티닌의 상승은 만성 신질환의 자연 경과이므로 SOFA 점수 변화에 반영하지 않는다
⑤ qSOFA 단독으로 패혈증을 확진할 수 있다

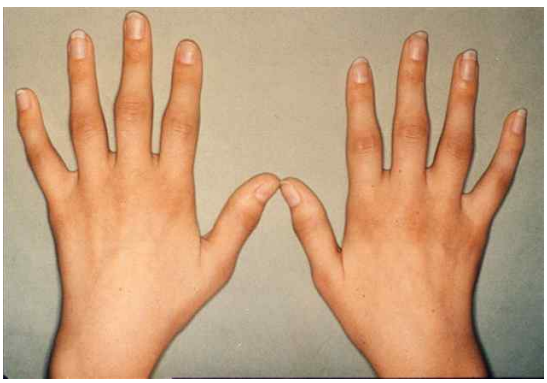
[류마티스내과] 5문항

53. 17세 남자가 6개월 동안 요통으로 NSAID 치료 받았으나 호전이 없었다. 활력징후는 정상이었고, 촬영한 X-ray 사진은 다음과 같다. 적절한 치료는?



① MTX
② TNA-alpha inhibitor
③ naproxen
④ Sufasalazine
⑤ Anti-IL6

54. 47세 여자 4개월 전부터 지속되는 손가락 관절통으로 내원하였다. 일어나서 아침 1시간 동안 제일 심한 양상이었다. 환자 양손 사진은 다음과 같다. 치료로 가장 적절한 것은?



① MTX
② NSAIDs 단독 요법
③ Glucocorticoid
④ Sufasalazine

55. 56세 환자가 X달 전부터 팔과 다리에서 힘이 빠진다며 병원에 왔다. 1개월 전부터 숨이 찼고 손가락이 아프기 시작했다. 다리의 근력은 저하되어 있었다. 다음은 손 사진 및 폐 영상 소견이다. 혈액검사 결과는 다음과 같았다. 진단에 도움되는 자가항체는?



① Anti-Jo1
② Anti SS-A/Ro
③ Anti-cardiolipin
④ Anti-dsDNA
⑤ Anti-CCP

56. 56세 여자가 3개월 전부터 시작된 양쪽 어깨와 허벅지의 통증 및 근력 약화로 내원하였다. 3개월 전부터는 앉았다 일어나고 계단을 오르는 것이 힘들었고, 일주일 전부터는 옷 갈아입고 머리 빗는 것도 힘들어졌다고 한다. 눈꺼풀에 보라색 발진이 있었고 앞 목과 등도 붉다. 다음은 얼굴 사진이다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 의심되는 질환을 진단하기 위해 필요한 검사가 아닌 것은?

① 혈중 uric acid
② ACPA
③ RF
④ ANA
⑤ ESR

57. 70세 남성 5년 전에 무릎에 골관절염이 있었다. 관절이 좋지 않아 며칠 전 Local에서 관절 주사를 맞았다. 관절 주위에 붓기와 열감이 존재하고 관절통으로 인해 내원하였다. 혈액 검사 결과상 WBC 6,800, CRP 7.5, ESR 67이었으며 관절액 천자 결과는 WBC 12,000, 결정은 없었다. 다음으로 시행할 처치로 가장 적절한 것은?

① 관절 내 스테로이드 주사
② IV 항생제
③ NSAIDs
④ 경구 스테로이드

[혈액종양내과] 5문항

58. (정말 많은 검사가 주어져서 정확한 복기가 어려웠습니다.) 요통이 있는 환자, 움직이면 요통이 심해지고 가만히 누워있으면 아프지 않아 계속 누워있는 XX세 여자 환자의 검사 결과가 다음과 같다. (다발성 골수종의 증상인 CRAB가 있었습니다. 다음은 주요 검사 결과들입니다.)

- IgG kappa 4,000, M protein 5.5, Albumin 2.4, beta 2 microglobulin 4.3
- Bone marrow cellularity 49%

이 환자에서의 병명과 단계는?

① Monoclonal gammopathy of undetermined significance
② Multiple Myeloma - smoldering
③ Multiple Myeloma - ISS I
④ Multiple Myeloma - ISS II
⑤ Multiple Myeloma - ISS III

59. (30줄 정도의 정말 많은 검사가 주어져서 정확한 복기가 어려웠습니다) DLBCL이라고 진단되었던 37세 남자 환자가 병원에 내원하였다. 환자는 ECOG PS 2점이었다. 다음은 검사 결과이다(모든 소견은 영어로 주어졌습니다).

· CBC: Hb 감소
· Blood chemistry: LDH 452
· PET-CT 소견
: neck II, III, IV에 최대 5cm의 림프절 비대 관찰됨
: supraclavicular에 최대 4cm의 림프절 비대 관찰됨
: right axilla에 최대 3.5cm의 림프절 비대 관찰됨
: pelvic, abdominal cavity에 림프절 비대 관찰되지 않음.
: hepatomegaly, splenomegaly는 관찰되지 않음.
· Bone marrow
: cellularity 50%
: lymphoid, plasma cell 침범 소견 없음

이 환자에서의 IPI risk category는?

① Low
② Low intermediate
③ High intermediate
④ High

60. 70세 여성이 어지러움과 피곤함을 주소로 병원에 내원하였다. WBC 3,000, Hb 6.7, PLT 57,000이었다. 골수검사 결과는 다음과 같다.

[골수검사] BM blast 12%, circulating blast X Chromosome -7 45 XY [7], chromosome 13 ?? 46 XY

이 환자에서의 IPSS risk group은?

① Low
② Intermediate -1
③ Intermediate -2
④ High

61. 29세 여자가 1주일 전부터 손, 발에 반점이 생겨 병원에 왔다. 가족력 없고 간질환이나 약물 복용력 없다. 발열이나 체중 감소 없다. 혈액검사결과는 다음과 같다. 다음에 시행할 검사는?

WBC 6,000, Hb 13, PLT 8,000, reticulocyte 1.1%, total bilirubin 0.3, Cr 1.0

① 항글로불린 검사
② 골수흡인 생검
③ 혈청 beta 2 저분자글로불린
④ 말초혈액펴바른표본검사

62. 70세 남성이 어지러움을 주소로 내원하였다. 환자는 50갑년의 흡연력을 가지고 있다. 다음은 환자의 혈액검사 결과이다. 이 환자의 치료로 가장 적절한 것은?

Hb 18 g/dL, EPO 30 (참고치: 〈29) 나머지 정상

① 금연
② 아스피린
③ 글리벡
④ 하이드록시유리아